

Injerto de mucosa bucal (de la mejilla)

Información para el paciente · El injerto de mejilla que se usa para reconstruir su uretra o uréter

WARWIKI

Como parte de su cirugía reconstructiva, su cirujano usa un pequeño parche del revestimiento húmedo del interior de su mejilla — un injerto de mucosa bucal — para reconstruir su uretra (o, con menos frecuencia, su uréter, el conducto que va del riñón a la vejiga). Esta hoja explica por qué se usa la mejilla, qué sucede y cómo se sentirá y sanará su boca.

Acerca de este injerto

El interior de su mejilla está recubierto por un tejido resistente y húmedo que se adapta muy bien a las vías urinarias. Se toma un parche ovalado y delgado de una mejilla (a veces de ambas, para una reparación más larga) y se usa para ensanchar o reconstruir la zona estrecha. El injerto se toma **mientras usted está dormido, durante la misma operación** de su reparación.

¿Por qué el interior de la mejilla?

- No tiene vello y está acostumbrado a un ambiente húmedo, como las vías urinarias
- Es resistente, sana rápido con poca cicatriz y resiste las infecciones
- Se toma durante la misma cirugía — sin un corte adicional en su cuerpo y sin cicatriz visible

¿Es seguro?

Sí. Tomar un injerto de la mejilla es una parte bien establecida y bien tolerada de la cirugía uretral, con una satisfacción muy alta de los pacientes. Su cirujano se mantiene alejado del conducto que drena la saliva y de la comisura de la boca. La mayoría de los efectos afectan a la boca — dolor, tensión o entumecimiento — y mejoran durante las primeras dos semanas. Tomar injerto de ambas mejillas causa más molestias, por eso solo se hace cuando una reparación más larga lo requiere.

APRENDA LOS TÉRMINOS

Mucosa bucal

El revestimiento húmedo del interior de su mejilla.

Injerto

Un parche de su propio tejido que se traslada para reparar otra zona.

Uretra

El conducto que lleva la orina hacia afuera del cuerpo.

Uretroplastia

Cirugía para reparar o reconstruir la uretra; el injerto de la mejilla forma parte de ella.

Sitio donante

El lugar de donde se toma el injerto — aquí, el interior de su mejilla.

Anestesia general

Medicamento que lo mantiene dormido y sin dolor durante la cirugía.

Conducto de la saliva (parótida)

Una pequeña abertura dentro de la mejilla que drena la saliva; su cirujano la evita.

Trismo

Tensión temporal o dificultad para abrir bien la boca; mejora con estiramientos suaves.

¿LE DOLERÁ? El injerto se toma mientras usted está dormido bajo anestesia general, así que no siente nada durante la cirugía. Después, la mejilla queda adolorida — como una mordida en la mejilla o una llaga en la boca — y puede sentirse tensa o entumecida. El dolor mejora durante las primeras 1–2 semanas, y la mejilla sigue sanando en las semanas siguientes. La mayoría de las personas toman líquidos en un día y vuelven a una dieta normal en una semana.

Cómo prepararse (antes de su cirugía)

- El injerto se toma durante su cirugía reconstructiva, **bajo anestesia general** — siga todas las instrucciones habituales de la cirugía (ayuno y qué medicamentos suspender).
- **Cuide su boca** de antemano — cepílese y enjuáguese bien; su equipo puede pedirle que primero se haga una limpieza dental.
- **No fume, no vapee ni use tabaco** — esto retrasa la sanación de la boca y del injerto. Dejarlo antes de la cirugía ayuda mucho.

Avise a su equipo con anticipación si usted:

- Ha tenido cirugía de la boca, la mejilla o la mandíbula, o radiación en la cabeza o el cuello
- Tiene una afección en la boca o dificultad para abrir bien la boca
- Masca tabaco o nuez de betel, o tiene problemas dentales continuos

Qué sucede durante la cirugía

- 1 Usted está dormido bajo anestesia general durante toda la operación, y su boca se mantiene abierta con suavidad.
- 2 Su cirujano retira un parche ovalado y delgado del revestimiento de una mejilla (de ambas mejillas para una reparación más larga), manteniéndose alejado del conducto de la saliva y de la comisura de la boca.
- 3 El injerto se moldea y se usa para ensanchar o reconstruir la parte estrecha de sus vías urinarias.
- 4 Por lo general, la mejilla se deja sanar por sí sola o se cierra con puntos que se disuelven.

Después de la cirugía (su boca)

- **Dos etapas:** el dolor y la tensión **mejoran en 1–2 semanas**, pero la mejilla sigue sanando cerca de un mes y el **entumecimiento puede tardar un mes o más**.
- Coma **alimentos blandos** al principio; evite lo picante, ácido, muy caliente o crujiente y el alcohol. Enjuáguese con suavidad.
- Cada día, **estire la boca** con suavidad. **No hay cicatriz visible** — el injerto está dentro de la boca.

Llame a su equipo si tiene:

- Fiebre o escalofríos
- Sangrado abundante o continuo de la boca
- Empeoramiento del dolor de boca, hinchazón o pus (infección)
- No puede tomar líquidos ni abrir la boca en absoluto

TRES COSAS PARA RECORDAR

1. Se usa un pequeño parche del interior de su mejilla para reconstruir su uretra — sin vello, sana bien y sin cicatriz visible.
2. Se toma mientras usted está dormido durante la reparación. Siga las instrucciones de ayuno y medicamentos, cuide su boca y no fume.
3. La mejilla quedará adolorida, tensa o entumecida — **mejora en 1–2 semanas, pero tarda un mes o más en sanar del todo**. Coma alimentos blandos, enjuáguese con suavidad y estire la boca a diario. Llame si hay fiebre, sangrado abundante o hinchazón.